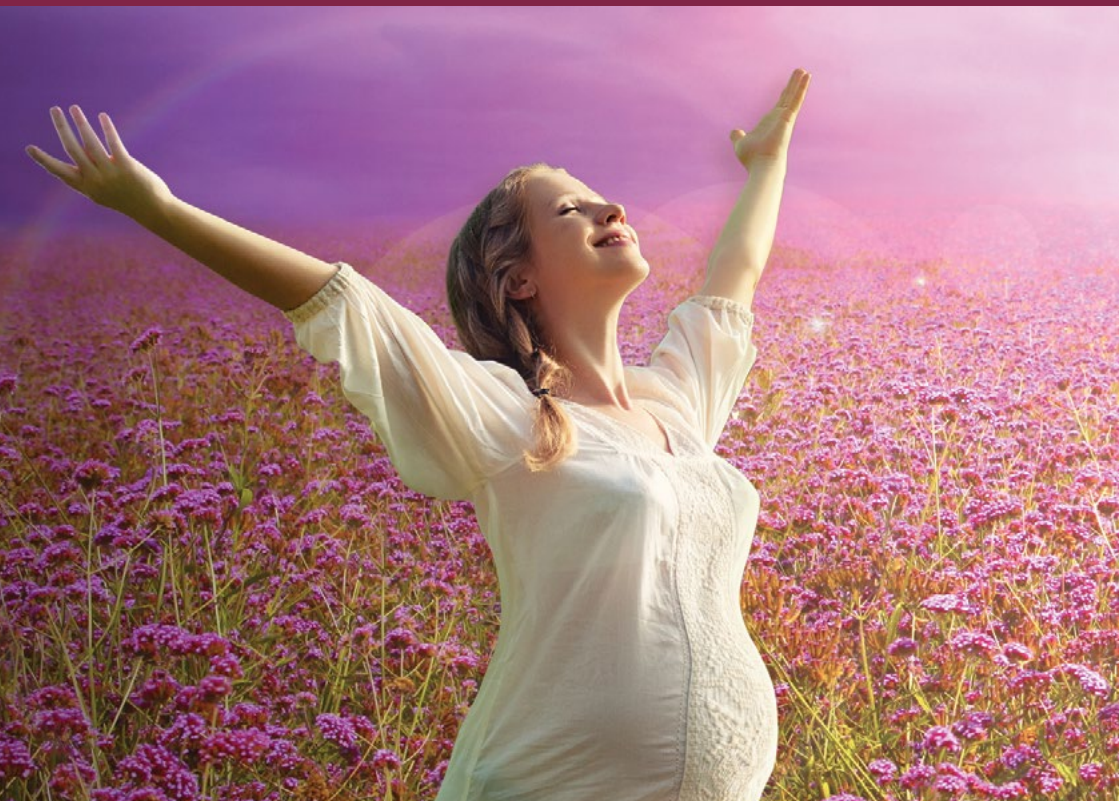


ROYALE HAYAT HOSPITAL



مستشفى رويال حياة



ترتيبات ولادتي

2536 0000
www.royalehayat.com



خطة الولادة هي أحد الأمور التي ترغبين بها أثناء إقامتك في المستشفى، تُشجّع الأمهات على إكمال خطة الولادة من خلال المناقشة مع قابلة دعم الولادة / إستشاري الولادة حول رغباتك ومشاعرك وما يناسبك. بعد الانتهاء يمكن تقديم الخطة ومناقشتها مع دكتور الولادة الخاص بك. تُسلم نسخة لك ويُحتفظ بنسخة أخرى في ملفك الخاص.

لماذا نحتاج إلى خطة الولادة؟

قد ترغبين أنت وزوجك في الحصول على ولادة مثالية، لذلك تحتاجين إلى وضع خطة للولادة ليعرفها الجميع. يجب أن تناقشي خطة الولادة مع طبيبك الاستشاري في الفترة ما بين ٣٢-٣٤ أسبوعاً من الحمل. بهذه الطريقة؛ لن تحصل مفاجآت. سيُخبرك طبيبك الاستشاري ما توفره وتوافق عليه المستشفى من اختيارات الأزواج الشخصية. بعد المناقشة مع الاستشاري، يجب إتمام خطة الولادة.

هل أحتاج إلى كتابة خطة ولادتي؟

لدى مستشفى رويال حياة نموذج قياسي يمكنك إستكماله كما تشائين. أثناء فترة الحمل يُوصى بمراجعة خطة الولادة الخاصة بك مع إستشاري الولادة. حاولي معرفة إذا كان إختيارك لمكان الولادة يلبي رغباتك. على سبيل المثال، إذا كان لديك حمل شديد الخطورة، فقد ينصحك طبيبك بأمور معينة في خطتك للولادة. إنها فكرة جيدة أن تجري هذه المحادثة قبل وصولك إلى المستشفى.

ما الذي يجب أن تتضمنه خطة الولادة؟

إذا لم يكن لديك خطة جيدة للولادة قد لا يتم الأخذ بالطريقة التي تفكرين بها للولادة طفلك .

أمور مهمة يجب معرفتها عنك:

* التعرف عليك وعلى المتطلبات الخاصة بك من أهم الأمور التي يجب على مقدم الرعاية الصحية. مثال تساعد معرفة فيما إذا كان لديك حساسية من بعض الأطعمة أو الأدوية في تجنب أي خطر يحدث أثناء الولادة.

* تساعد الأجواء الهادئة وتقليل التوتر على تشجيع ودعم الولادة الطبيعية. تعزّز المستويات المنخفضة من هرمونات التوتر أثناء المخاض والولادة تدفق الدم في الرحم وتدعم صحة حديثي الولادة، في حين أن المستويات المرتفعة من هرمونات التوتر يمكن أن تطيل المخاض وتعيق الولادة.

* يمكن أن تؤثر الثقافات المختلفة والمبادئ والمعتقدات على احتياجات المرأة وتوقعاتها أثناء الحمل والولادة، فضلاً عن كيفية تربية أطفالها.

المرحلة الأولى من المخاض:

في المرحلة الأولى من المخاض؛ تساعد إنقباضات الرحم على توسيع عنق الرحم. يستمر عادةً حوالي ١٢ ساعة بالنسبة للمولود الأول، ومن ٧ إلى ٨ ساعات للمولود الثاني. يمكنك اختيار طرق مختلفة لجعل المرحلة الأولى من المخاض مريحة قدر الإمكان، مثل الاختيارات أدناه:

– **كرة الولادة** – يساعد الجلوس على كرة الولادة على زيادة تدفق الدم إلى الرحم وكذلك إلى المشيمة بالإضافة إلى المساعدة في فتح الحوض. يساعدك استخدام كرة الولادة أثناء المخاض على تقدّم سير المخاض جيّدًا.

– **هل تريد التحرك بحرية أثناء المخاض؟** تكون المحافظة على الحركة والتنقل في غرفة الولادة وفقًا لنصيحة الطبيب.

– **الإضاءة الخافتة** – قد تسهّل الولادة وتزيد الاستمتاع بالمرحلة التي تمر بها المرأة وطفلها، ممّا يوفر الخدمة المثالية للمرأة وفريق الرعاية الطبية.

ملاحظتك أنت وطفلك:

سيكون للطبيب القرار النهائي حسب الحالة.

– **مراقبة قلب الجنين** – هي طريقة للتحقق من معدل ضربات قلب (الجنين) أثناء المخاض. يعدّ معدل ضربات القلب طريقة جيدة لمعرفة وضع الجنين وحالته إذا كانت جيدة أو إذا كان هناك مشكلة. يمكن إجراء المراقبة طوال الوقت أثناء المخاض (مستمر) أو في أوقات محددة (متقطعة).

– **الملاحظة المتقطعة**، تستخدم الممرضة أو الطبيب جهازًا يدويًا للاستماع إلى قلب طفلك من خلال بطنك. يتم فحص معدل ضربات القلب في أوقات محددة أثناء المخاض. على سبيل المثال، في حالة الحمل بدون مشاكل، يمكن فحص نبضات قلب الطفل كل ٣٠ دقيقة خلال المرحلة الأولى من المخاض.

– تعني المراقبة المستمرة: **إستمرار المراقبة حتى إتمام الولادة.**

– **ملاحظة الإنقباضات:** أي مريضة يتطوّر لديها المخاض بشكل طبيعي، ستكون لديها انقباضات كافية وفعالة بغض النظر عن مدّة الانقباضات وتواليها. قد تكون انقباضات الرحم غير الطبيعية غير كافية أو غير فعالة.

– **تقلصات الرحم غير الكافية** – قد تكون تقلصات الرحم فعالة لكن غير كافية، وقد يضعف المخاض رغم وجود تقلصات تبدو جيدة ومؤلمة.

أودّ تواجد هؤلاء الأشخاص معي:

* في الوقت الحالي يسمح بحضور شريك المريضة إلى غرفة المخاض والولادة. تذكرني أن قوانين المستشفى تطبق من أجل سلامتك، وليس لإزعاجك.

* ومن البديهي أنه يمكنك التقاط صور لمولودك الجديد. - لكن يعتمد هذا على حالتك تجنباً لإلحاق الضرر بك وبطفلك.

* **دعم الولادة بتقنية (لاماز)** - وهي خدمة خاصة للأهات في المخاض يقدمها فريق متخصص ومدرب يساعد الحامل في الحصول على الوضعية وممارسة الرياضة بشكل صحيح أثناء المخاض. سيساعد الدعم الجسدي والنفسي والعاطفي المستمر على ضمان التقدم السلس للولادة. سيوجهك الفريق لاتخاذ القرار.

ملاحظة: يتوفر برنامج دعم الولادة المعنوي أو برنامج لاماز في المستشفى. في حالة المخاض أو الولادة القيصرية. يتوفر لدينا كتيب لاماز.

ملاحظة: طبيبك الاستشاري سيشرح لك كل خيار من هذه الخيارات.

تحفيز المخاض:

هو مساعدة إنقباضات الرحم أثناء الحمل من أجل ولادة طبيعية. قد يوصي الاستشاري بتحفيز المخاض لأسباب مختلفة، بشكل أساسي إذا كان هناك خطر على صحة الأم أو الجنين.

* **البروستاغلاندين** - الذي يتم إدخاله في عنق الرحم فعال في بدء المخاض، يكمن الدور الأساسي لهذه المركبات في فتح وتوسيع عنق الرحم استجابة للانقباضات.

* **قطع السلي** - يعرف أيضاً (بتمزق الأغشية الاصطناعي) (AROM) "نزل ماء الرأس"، هو التمزيق المتعمد للكيس الأمنيوسي من قبل طبيب التوليد. يساعد هذا على سرعة المخاض، مما يسمح بمراقبة أكثر مباشرة لحالة الجنين.

تسريع المخاض:

هي عملية تحفيز الرحم لزيادة وتيرة التقلصات شدتها ومدتها بعد بدء المخاض الطبيعي. يستخدم لعلاج تأخر الولادة عندما يكون ضعف تقلصات الرحم السبب الأساسي لتأخر الولادة.

* **سينتوسينون / أوكسيتوسين** - إذا كانت عضلات الرحم تنقبض بالسرعة المتوقعة / أو تباطأت التقلصات أو توقفت أو أصبحت غير منتظمة، فقد يعطيك

طبيبك جرعة من سينتوسينون (شكل إصطناعي من هرمون الأوكسيتوسين الذي يسبب تقلصات الرحم) من خلال الحقن الوريدي.

*** قطع السلى** – (راجع الوصف أعلاه).

الولادة القيصرية – هي الولادة الجراحية للجنين من خلال إجراء شق جراحي في بطن ورحم الأم.

*** التخدير النصفى** – (أو التخدير النصفى أو إبرة الظهر) – دواء مخدر يتم حقنه باستخدام إبرة صغيرة جدًا، مباشرة في السائل الذي يحيط بالحبل الشوكي. يعمل التخدير النخاعي على تخدير النصف السفلي من الجسم. لن تكوني قادرة أحيانًا على تحريك ساقيك لبضع ساعات.

*** التخدير فوق الجافية (إبرة الظهر)** – دواء مخدر يتم حقنه حسب الحاجة في قسطرة بلاستيكية رفيعة مثل الخيط تم وضعها في فراغ فوق الجافية. القسطرة مؤمنة من الخلف بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى إذا دعت الحاجة إلى المزيد وذلك في الحالتين التاليتين:

– أثناء عملية المخاض، إذا شعرت أن الانقباضات تزداد قوة وأكثر إيلًا.

– في حالة انتقالك من الولادة الطبيعية إلى الولادة القيصرية.

*** التخدير المقترن** (النصفى وفوق الجافية معًا) – يقدم فوائد التخدير النخاعي والتخدير فوق الجافية معًا.

*** التخدير العام** – ينتج عنه فقدان كامل للإحساس والوعي. أثناء التخدير العام، لا يمكنك الشعور بالألم ولا يستجيب جسمك لردود الفعل. عملية تحاكي النوم الطبيعي. عادة ما يوصف مسكن الألم القوي لتسكين الألم بعد التخدير العام.

ملاحظة: سيقم طبيب التخدير حالك وسيوفر شرحًا لكل هذه المعلومات.

طرق المفضلة لتخفيف الألم:

ما نوع مسكنات الآلام التي يمكنني الحصول عليها؟
إذا كنت تخططين لعدم استخدام الأدوية، يمكنكِ عمومًا استخدام مسكنات الألم في أي وقت.

إجراءات غير طبية:

* **الاسترخاء** – التخفيف من مشاعر التوتر – يمكنكِ من السيطرة على ذاتك. تخفيف الألم – عن طريق تخفيف توتر العضلات وآلامها. يطلق مادة الإندورفين (مركبات طبيعية مسكنة للألم) لتخفيف الألم.

* **التدليك** – تخفيف الألم في العضلات والمفاصل (خاصة الظهر، والذي يمكن أن يصاب بالألم في كثير من الأحيان أثناء الحمل) يحسن الدورة الدموية والأكسجين في الدم، مما قد يكون مفيدًا للجنين. تخفيف التورم وتوتر العضلات.

* **أكسيد النيتروز الممزوج مع الأكسجين**. لن يزيل الغاز والهواء كل الآلام، لكن يمكن أن يساعد في تخفيفه وجعله أكثر احتمالًا.



وضعية الجسم:

عند الاستلقاء وأثناء تقلصات المخاض، يضغط رأس الطفل على أعصاب الحوض. لكن مع أخذ وضعيات مختلفة أثناء المخاض، يقلل الضغط والسمام لرأس طفلك بالضغط نحو عنق الرحم.



* **التأرجح:** لفي ذراعيك حول رقبة مرافقك وتمايلي كما لو كنت ترقصين ببطء.



* **إمالة الحوض:** ارفعي قدمي واحدة على كرسي أو مسند قدم وانحني للأمام.



* **القرفصاء:** خذي وضعية القرفصاء وتمسكي بظهر كرسي ثابت ويمكن أيضا القرفصاء بين ساقَي شريكك أثناء جلوسه على كرسي ثابت.



* **التأرجح:** اهتزي برفق أثناء الجلوس على الكرسي أو حافة السرير أو كرة الولادة.



* **اليدين والركبتين:** الجثو على المرفقين والركبتين على الأرض أو سجادة اليوغا.



* **مسند الولادة:** مسند الولادة عبارة عن ملحق يمكن إضافته إلى معظم أسرة الولادة للمساعدة في تسهيل وضع القرفصاء. يساعد وضع القرفصاء على توسيع حجم حوضك، ويستخدم الجاذبية لتعزيز الحركة الهبوطية لطفلك. عند استخدام المسند، يمكن إسقاط قدم السرير ورفع رأس السرير عالياً. بين الانقباضات، يمكنك الجلوس، مدعومة برأس السرير، ثم أثناء الانقباضات، ثم تحركي القرفصاء مباشرة، بمساعدة المس.

الأدوية:

* **باراسيتامول** – يستخدم للعلاج قصير الأمد للألم المعتدل.

* **باسكوبان (مضاد للتقلص)** – فعال في تقليل مدة المرحلتين الأولى والثانية من المخاض بشكل ملحوظ ولا يأتي بأي نتائج عكسية واضحة على الأم أو الجنين.

* **بيثيدين (مسكن قوي)** – يستخدم لعلاج الألم، خاصة أثناء الولادة. يُعطى عادة عن طريق الحقن العضلي أو الوريدي ويخفف الألم لمدة تصل إلى أربع ساعات. الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للأمهات هي الشعور بالدوار أو النعاس والتعرق والشعور بالغثيان. وله أيضًا تأثيرات جانبية محتملة لحديثي الولادة مثل الرضاعة المتأخرة والقليلة.

* **فوق الجافية (ابرة الظهر)** – هو إجراء يتم فيه حقن مسكنات الألم في الفراغ المحيط بالأعصاب الشوكية في أسفل الظهر. فعال للغاية بعدد الشعور بالألم من تقلصات المخاض وأثناء الولادة. باستخدام حقنة الظهر، يمكنك التحرك ويمكن دفع الجنين للخارج عندما تحتاجين إلى ذلك.

بعد ولادة طفلي، كيف أعبر عن رغباتي؟

لا تنتهي خطة الولادة بعد ولادة طفلك. فريقنا يود معرفة كيف تريد رعاية طفلك في مستشفىنا. يجب أيضًا تضمين التفضيلات الدينية أو الثقافية في خطتك.

* **قطع الحبل السري المتأخر** – يعني أن الأطباء لا يقومون بشد الحبل السري وقطعه على الفور. يتيح ذلك وقتًا إضافيًا لتدفق الدم في الحبل السري والمشيمة إلى الجنين. يرتبط بفوائد كبيرة للمولود الخدج، يساعد على تحسين الدورة الدموية الجنينية الانتقالية، وتحسين حجم خلايا الدم الحمراء، وانخفاض الحاجة إلى نقل الدم.

* **اللامسة الجسدية الفورية المباشرة** – خلال الساعة الأولى بعد الولادة، تمر كل من الأم والرضيع بفترة خاصة وفريدة من نوعها، وهي فترة حساسة تم تحديدها مسبقًا بيولوجيًا، خاصة بعد الولادة الطبيعية. إن التلامس للجنين مع الأم بعد الولادة يعمل على إثارة ما يمكن تسميته بالمراحل الغريزية: البكاء عند الولادة، والاسترخاء، والاستيقاظ، والنشاط، والراحة، والتأقلم، والرضاعة والنوم.

* **الولادة الطبيعية للمشيمة** – يبدأ طرد المشيمة كإنفصال طبيعي عن جدار الرحم عبر المهبل. الرضاعة الطبيعية، فلامسة الجلد للجلد يزيد من إفراز هرمون الأوكسيتوسين، الذي يعمل على سهولة الولادة الطبيعية للمشيمة.

ملاحظة: استشاري طب الأطفال حديثي الولادة متاح للاستشارة قبل الولادة إذا كنت تريد معرفة المزيد عن طفلك لما بعد الولادة.

تغذية المولود:

* **الرضاعة الطبيعية** – تعتبر أفضل غذاء للمولود وأفضل فرصة للرضاعة الطبيعية خلال أول ساعتين بعد الولادة تمنحك ارتباطاً وثيقاً بالمولود ويتمتع طفلك بجميع فوائد اللبن الذي يعزز الجهاز المناعي، المساعدة في ضمان حدوث ذلك هي تضمين الرضاعة الطبيعية في خطة الولادة الخاصة بك.

* **الرضاعة الصناعية** – هناك عوامل قد تمنع الرضاعة الطبيعية لدى الأم وتلجأ للرضاعة بالزجاجة، لا داعي للتوتر والقلق بشأن استخدام الحليب الاصطناعي فطفلك يحتاج للبقاء بصحة جيدة وسعادة. وليس أن يكون متوتراً أو قلقاً بشأن الرضاعة الصناعية.

* **التغذية المختلطة** – إن إعطاء طفلك حليباً اصطناعياً بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية يسمى بالمكملات الغذائية. إنه أمر جيد تماماً وأمن تماماً، وتختار العديد من العائلات هذا النوع من طرق التغذية المركبة، سواء بدافع الضرورة (على سبيل المثال، انخفاض كمية حليب الثدي)، أو من أجل الراحة، وفي بعض الحالات قد يوصي الطبيب بالرضاعة الطبيعية وتوفير الحليب الصناعي لأسباب طبية.

* **شفط حليب الثدي** – يعني عصر الحليب من ثديك حتى تتمكني من تخزينه وإطعامه لطفلك لاحقاً. قد ترغبين في شفط الحليب عند إضطرارك للابتعاد عن طفلك، على سبيل المثال، إذا كان طفلك يحتاج رعاية خاصة أو عند عودتك للعمل.

ملحوظة: إستشارية الرضاعة الطبيعية متاحة لأي أسئلة واستفسارات. نشرة الرضاعة الطبيعية متوفرة.

تواجد المولود:

* **في الغرفة** وهي الأسلوب المتبع في مستشفى رويال حيث يتم الاحتفاظ بسرير الطفل بجانب سرير الأم. مما يمنح الوالدين معرفة طفلهما وتوثيق ارتباطهما بالمولود.

* **الحضانة** – يُحتفظ بالطفل في حضانة المستشفى ويتم إحضاره إلى الأم لإرضاعه.

فحص حديثي الولادة:

* إلزامي حسب وزارة الصحة بدولة الكويت

* إختبار فحص الأطفال حديثي الولادة للكشف عن الاضطرابات الوراثية والأبيض والغدد الصماء وأمراض الدم التي لا تظهر بالفحص والتشخيص العادي عند الولادة، إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها مبكرًا يمكن أن تكون ضارة ومميتة أحيانًا.

- يفضل أن يتم فحص حديثي الولادة بعد أول ٣٦ ساعة، بمجرد بدء الرضعات سواء حليب الأم، الحليب الاصطناعي.
- يتم إرسال فحص حديثي الولادة إلى مختبرات خارجية والفترة الزمنية اللازمة لظهور النتيجة ١٠ أيام من العمل.
- إذا إختار الوالدان عدم المتابعة مع طبيب الأطفال في المستشفى، فمن حقهم الحصول على نسخة من نتيجة الفحص الخاصة بطفلهم عند طلبهم ذلك.

فيتامين K

* فيتامين K من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لتخثر الدم، مما يساعد على التئام الجروح. هناك أيضًا بعض الأدلة على أن فيتامين K قد يساعد في الحفاظ على صحة العظام.

* يعاني الأطفال من نقص نسبي في فيتامين K وأولئك الذين لا يتلقون المكملات الغذائية معرضون لخطر النزيف. يتم إعطاؤه بشكل روتيني لجميع الأطفال بموافقة الوالدين.

لقاح التهاب الكبد البائي B

* إلزامي حسب وزارة الصحة الكويتية.

- التهاب الكبد البائي - هو عدوى فيروسية تصيب الكبد ويمكن أن تسبب أمراضًا حادة ومزمنة.
- ينتقل الفيروس بشكل شائع من الأم إلى الطفل أثناء الحمل والولادة.
- يمكن الوقاية من التهاب الكبد - عن طريق اللقاحات الآمنة والمتوفرة والفعالة.

الختان:

* يتم الاستئصال الاختياري لقلعة القضيب. يتم إجراؤها للمواليد (الذكور) قبل مغادرته المستشفى، وغالبًا خلال اليومين الأولين من ولادته.

* يتم إجراء الختان بموافقة الوالدين.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، يمكنك سؤال أطبائنا حديثي الولادة. نشره الختان متوفرة.

فحص السمع:

يولد طفل أو طفلان من بين كل ١٠٠٠ طفل مصاب بفقدان سمع دائم في إحدى الأذنين أو كليهما.

* ترتفع نسبة الإصابة إلى حوالي ١ من كل ١٠٠ طفل أمضوا أكثر من ٤٨ ساعة في العناية المركزة.

يولد معظم هؤلاء الأطفال في أسر ليس لها تاريخ من فقدان السمع الدائم.

* يمكن أن يؤثر فقدان السمع الدائم بشكل كبير على نمو الأطفال.

* يمكن أن يمنح الاكتشاف المبكر هؤلاء الأطفال فرصة أفضل لتطوير مهارات اللغة والكلام والتواصل.

هام: يعاني الأطفال المصابون بفقدان السمع من صعوبات في التواصل اللفظي وغير اللفظي؛ زيادة مشاكل السلوك وانخفاض الصحة النفسية والاجتماعية وانخفاض التحصيل التعليمي مقارنة بالأطفال ذوي السمع الطبيعي

الفحص المبكر: نظراً لأن نصف الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع ليس لديهم عوامل خطر ظاهرة، يوصى بإجراء فحص شامل للكشف عن فقدان السمع الخلقي الدائم. هناك أدلة جيدة على أن فحص سمع حديثي الولادة المبكر بدقة متناهية يؤدي إلى الاكتشاف والعلاج المبكر.

فوائد الكشف والعلاج المبكر

* الاكتشاف المبكر يحسن النتائج اللغوية والتواصلية.

ملاحظة: نشرة اختبار فحص السمع متاحة.

فحص العيوب الخلقية الحرجة للقلب CCHD

* أهمية فحص حديثي الولادة لعيوب القلب الخلقية الحرجة.

* يمكن أن يساعد فحص عيوب القلب الخلقية الحرجة في تحديد بعض الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية قبل عودتهم إلى المنزل من مستشفى الولادة. هذا يسمح لهؤلاء الأطفال بالعلاج المبكر وقد يمنع الإعاقة أو الموت في وقت مبكر من الحياة.

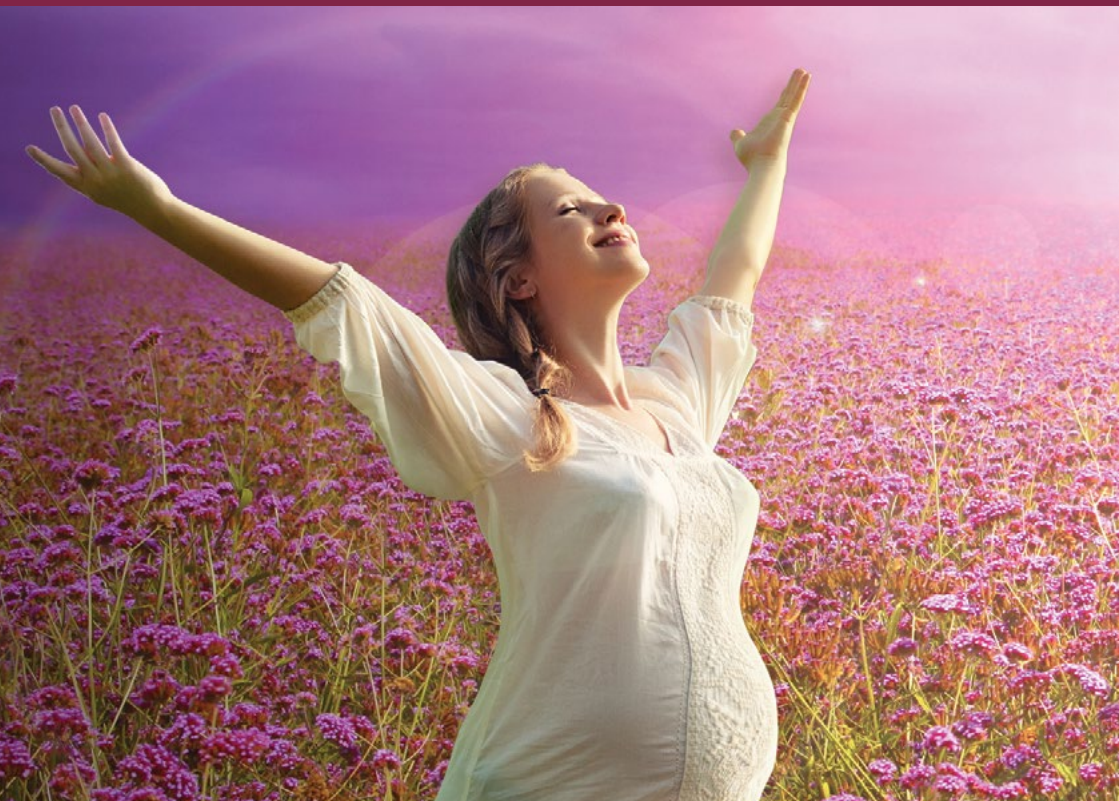
ملاحظة: لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى نشرة فحص أمراض القلب الخلقية الحرجة.

خطة الولادة الخاصة بك مصممة لتلبية رغباتك الشخصية. ضع في اعتبارك أنه قد تكون هناك ظروف يحتاج فيها فريقنا إلى الخروج عن الخطة لضمان خدمة أكثر أماناً. تذكر أن الهدف النهائي أثناء الولادة هو الحصول على أم معافاة وطفل سليم. يمكن أن تساعد خطة الولادة في توصيل رغباتك لفريق الرعاية خلال أهم الأوقات إثارة في حياتك.

ROYALE HAYAT HOSPITAL



مستشفى رويال حياة



My Birth Plan

2536 0000
www.royalehayat.com



A birth plan is one thing you would like to transpire during your hospital stay, Mothers are encouraged to complete the birth plan upon discussing with birth support midwife / Lamaze consultant for your wishes, feelings and priorities. Once completed, it can be given to, and discussed with your obstetrician. A copy will be given to you and will be placed in your file.

Why a birth plan is needed?

You and your spouse know what you would ideally like to have for your labor and delivery, but you need to make your birth plan so that everyone else know. You should discuss it with your consultant between your 32-34 weeks of pregnancy. In this way, there will be no surprises. Your consultant can also tell you the amount of flexibility the hospital allows couples in their personal choices. After discussions with your consultant, you should complete your Birth plan.

Do I need to write my own birth plan?

Royale Hayat Hospital has a standard form that you can complete at your own convenience. It's recommended to review your birth plan with your consultant during your pregnancy. Find out if the location at which you are delivering can accommodate your wishes. For example, if you have a high risk pregnancy, your provider may advise against certain things on your birth plan. It's a good idea to have this conversation before you arrive to the hospital.

What needs to be included in the birth plan?

Although you may have in your mind how you want your baby's birth to be, your choices may not be heard effectively if you don't have a birth plan.

Important things to know about me:

* Getting to know you and your requirement is one of the most important things for the healthcare provider should know. Like the allergies that you may have, either food, medicine, etc. This will avoid any danger that might happen while you are about to give birth.

* A birth environment that is calming, reduces stress and supports physiological birth. Low levels of stress hormones during labor and birth promote uterine blood flow and support neonatal well-being, whereas greater levels of stress hormones can lengthen labor and impede the neonatal transition.

* Different cultures have different values, beliefs and practices. Women's cultural background can affect their needs and expectations during pregnancy and childbirth, as well as how they and their family raise their children.

First stage of labor:

On the first stage of labor contractions help your cervix to thin and begin to open. This is called effacement and dilation. This usually lasts about 12 hours for a first baby, and 7 to 8 hours for a second child. You can choose different ways to make your 1st stage of labor as convenient as possible, like below choices.

* **Birth ball** – sitting legs wide open on your birthing ball helps to increase blood flow to the uterus as well as the placenta and your baby as well as helping open up the pelvis and hips. Using a birthing ball during labor allows you to get into positions which can help progress effectively.

* **Maintain mobility** – Do you want to freely move around during labor? Maintain mobility in delivery room according to Doctor's advice.

* **Dim Light** - may facilitate the delivery and increase attention to the moment experienced by the woman and her baby, providing autonomy for the woman and humanized care on the rest of the team.

Monitoring you and your baby

- The doctor will have the final decision depending on the case.

* **Monitoring fetal heart** – is a way to check the heart rate of your baby (fetus) during labor. The heart rate is a good way to find out if your baby is doing well at the same time. It can show if there is a problem. Monitoring may be done all the time during labor (continuous) or at set times (intermittent).

- Intermittent monitoring, the nurse or doctor uses a handheld device to listen to your baby's heart through your belly. The heart rate is checked at set times during labor. For example, in a pregnancy with no problems, the baby's heartbeat might be checked every 30 minutes during the first stage of labor.

- Continuous monitoring means to continue the monitor until delivery.

* **Monitoring contraction** –Any patient in whom labor progresses normally has both adequate and effective contractions, irrespective of the duration and frequency of contractions. Abnormal Uterine contractions may either be inadequate or ineffective.

- Inadequate uterine contractions. Can be the cause of poor progress of labour.

- Ineffective uterine contractions. The uterine contractions may be adequate but not effective, as poor progress can occur even in the presence of apparently good, painful contractions.

I would like these people and items with me:

* Today's labor and delivery room is open to more than just the person giving birth and their partner. Remember that hospital policy is in place for your safety, not to annoy you.

* It goes without saying that you can have photos of your newborn baby.

- But this depends on your situation to avoid harm to you and to your baby.

* **Birth Support (Lamaze)** - It is a special service, provided to mothers in labor by a specialized hospital team, trained to help and assist mother's position and exercise properly during labor. Continuous physical, psychological and emotional support will help ensure seamless progress of labor. They will guide you in decision making.

Note: Birth Support or Lamaze Program is available in our hospital. Lamaze Leaflet is available.

In the case of Induction of labor or Cesarean Section:

Note: Your consultant is ready to explain to you each of this choices.

Induction of labor - is the stimulation of uterine contractions during pregnancy to achieve vaginal birth. A consultant might recommend labor induction for various reasons, primarily when there's concern for mother's or baby's health.

* **Prostaglandin** - inserted into the cervix are effective in starting labor, but are inferior to vaginal administration. Their role is to prepare the cervix and to help open the cervix in response to contractions.

* **Amniotomy** - also known as artificial rupture of membranes (AROM) "breaking the water," is the intentional rupture of the amniotic sac by an obstetric doctor. This influence the speed of labor, allowing for more direct monitoring of fetal status.

Augmentation of labor - is the process of stimulating the uterus to increase the frequency, duration and intensity of contractions after the onset of spontaneous labor. It has been used to treat delayed labor when poor uterine contractions are the underlying cause.

* **Syntocinon /Oxytocin** - If you're not dilating and effacing as quickly as expected and/or your contractions have slowed, stopped or become erratic, your practitioner may give you a dose of syntocinon (a synthetic form of the hormone oxytocin that causes your uterus to contract) through an IV drip.

* **Amniotomy** - (refer to above description).

Cesarean Section - is the surgical delivery of a baby through a cut (incision) made in the mother's abdomen and uterus.

* **Spinal Anesthesia** – Is anesthetic medicine that is injected using a much smaller needle, directly into the cerebrospinal fluid that surrounds the spinal cord. Then the needle is guided into the spinal canal. Spinal anesthesia numbs the lower half of the body. You won't be able to move your legs for few hours.

* **Epidural Anesthesia** – is the anesthetic medicine is injected into the catheter to numb the body above and below the point of injection as needed. The catheter is secured on the back so it can be used again if more medicine is needed.

* **Epidural top-up** – a technique is used whereby, anesthetists inject the anesthesia medicine via the existing epidural catheter. In the following two circumstances:

- During the labor process, if you feel contractions are getting stronger, & more painful.

- In case you move from normal delivery to surgery.

* **Combined spinal** - epidural Anesthesia - offers benefits of both spinal and epidural anaesthesia. CSEA also offers the prospect of reducing the anaesthetic failure rate to only a fraction if either technique used alone. It is a routine for Caesarean section in patients without an existing labour epidural in place, and who had no contraindications to regional anaesthesia.

* **General Anesthesia** - produces a total loss of sensation and consciousness. During general anesthesia, you can't feel pain and your body doesn't respond to reflexes. A process that mimics natural sleep. Strong Pain killer are usually prescribed to provide analgesia following GA.

Note: Anesthesiologist are available for pre-anesthesia assessment and will help explain you all this information.

My preferred methods of pain relief:

What kind of pain relief can I have? If you are planning on not using medications, although you can still receive pain relief medication at any point.

Non-medicinal

* **Relaxation** - Reduce the feelings of stress – you will feel more in control. Reduce pain - by decreasing muscle tension, aches and pains. Releases endorphins ('the body's natural pain-killers') to relieve pain.

* **Massage** - reduced pain in the muscles and joints (especially the back, which can often get sore during pregnancy) improved circulation and blood oxygenation, which can be helpful for your baby. Reduced swelling. Reduced muscle tension.

* **Entonox** - This is a mixture of oxygen and nitrous oxide gas (laughing gas). Gas and air will not remove all the pain, but it can help reduce it and make it more bearable.



Positioning:

When you're reclining during labor contractions, the baby's head puts pressure on pelvic nerves in your sacrum. But with different labor positions below reduces the pressure while allowing your baby's head to constantly bear down on your cervix.

Swaying: Wrap your arms around your partner's neck or waist and sway as if you are slow dancing. This is a great position to receive a back rub.



Lunging: Raise one foot onto a chair or footstool and lean forward.



Squatting: Hold on to the back of a sturdy chair and squat. You can also squat against a wall or between your partner's legs while he or she sits in a stable chair.



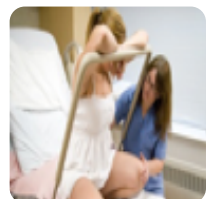
Rocking: Gently rock while sitting on a chair, the edge of the bed or a birthing ball.



Hands and Knees: Get on all fours on the bed, a yoga mat or on the floor.



Birthing Bar: A birthing bar is an attachment that can be added to most labor beds to help facilitate a squatting position. The squatting position helps to expand the size of your pelvis, and uses gravity to promote the downward movement of your baby. When using the bar, the foot of the bed can be dropped, and the head of the bed raised high. Between contractions, you can sit, supported by the head of the bed, and then during contractions, move forward to squat, supported by the bar.



Medication

* **Perfalgan (Paracetamol)** - is indicated for the short-term treatment of moderate pain

* **Buscopan (Antispasmodic)** - is effective in significantly reducing the duration of the first and second stages of labor and that it is not associated with any obvious adverse outcomes in mother or neonate.

* **Pethidine (Opioid analgesic)** – is used to treat pain, particularly during childbirth. It is usually given by injection and provides pain relief for up to four hours. The most common side-effects for mothers are feeling dizzy or sleepy, sweating, and feeling sick (nausea). It has also possible side effects for neonates like delayed and depressed sucking and rooting behavior.

* **Epidural** - is a procedure that injects pain killer medicines in to the space around the spinal nerves in your lower back. This anaesthetic usually blocks the pain from labour contractions and during the birth very effectively. With an epidural you can usually move and can push your baby out when you need to.

After my baby is born, how do I express my preferences?

A birth plan does not end with the delivery of your new baby. Our team wants to know how you want your baby to be cared for in our hospital. Religious or cultural preferences should be included in your plan as well.

* **Delayed cord clamping** - means that doctors don't immediately clamp and cut the umbilical cord. Instead, they allow extra time for the blood in the cord and placenta to flow to the baby.

It is associated with significant neonatal benefits in preterm babies, including improved transitional circulation, better establishment of red blood cell volume, and decreased need for blood transfusion.

* **Immediate skin-to-skin** - During this first hour after childbirth, both mother and newborn infant experience a special and unique time, a sensitive period, which has been biologically predetermined, especially after vaginal birth.

Being in skin-to-skin contact with the mother after birth elicits the newborn infant's internal process to go through what could be called instinctive stages: birth cry, relaxation, awakening, activity, rest, crawling, and familiarization, suckling and sleeping.

* **Physiologic birth of placenta** - the placenta is separated from the uterine wall and moved downward to the birth canal and expelled naturally through vagina. This approach is recommended for women with low risk of bleeding. When the baby is breastfed, the skin-to-skin contact increases the release of oxytocin, facilitating the natural delivery of the placenta.

Note: Consultant Neonatologist are available for prenatal consultation if you want to know more about your baby after delivery.

Baby Feeding:

* **Breastfeeding** – Giving your baby his first breastfeed within the first couple of hours after birth gives you the best chance of establishing breastfeeding, as well as giving him the chance to enjoy all the benefits of colostrum as soon as possible. One way of helping to ensure this happens is to include breastfeeding in your birth plan.

* **Bottle Feeding** – Some women have difficulty breastfeeding or are unable to and others may choose not to. Your baby needs you to stay healthy and happy, not stressed or worried about using formula.

* **Mixed Feeding** – Giving your baby formula in addition to breastfeeding is called supplementing. It's completely OK and perfectly safe to do, and many families choose this type of combination feeding method, whether out of necessity (e.g., low breast milk supply), convenience, or simply a personal choice. In some cases, breastfeeding and providing formula may be recommended by doctor for medical reasons.

* **Expressing Breast milk** - means squeezing milk out of your breast so you can store it and feed it to your baby later. You might want to express milk if:

* you have to be away from your baby, for example, because your baby is in special care or because you're going back to work

Note: Breastfeeding Counsellor is available for any questions and inquiry. Breastfeeding leaflet is available.

Separation:

* **Rooming-in** - is the practice followed in RHH where the baby's crib is kept by the side of the mother's bed. This arrangement gives an opportunity for the parents to know their baby. The bond between the parent and the child is well established in roomed-in babies.

* **Nursery** – is keeping the baby in the hospital nursery and the baby is brought to the mother for breastfeeding.

Newborn Screening:

* Mandatory as per MOH Kuwait

* New Born Screening Test (NBST) is the practice of screening new born babies for genetic, metabolic, endocrine and haematological disorders that are not otherwise apparent at birth, but can be harmful or potentially fatal if not detected & treated early.

- NBST should be collected preferably after the first 36 hours, once protein-containing feedings (i.e. Breastmilk, formula) have been started.

- NBST is a sent - out test and the turn-around time (TAT) is approximately 10 working days.

- If the parents choose not to follow up with a RHH pediatrician, it is their right to collect a copy of their baby NBST result, if so they desire.

Vitamin K:

* Vitamin K is a group of vitamins that the body needs for blood clotting, helping wounds to heal. There's also some evidence vitamin K may help keep bones healthy.

* Babies are relatively deficient in Vitamin K and those who do not receive supplements are at risk of bleeding. It is routinely given to all babies with parental consent.

Hepatitis B Vaccine:

* Mandatory as per MOH Kuwait

- Hepatitis B is a viral infection that attacks the liver and can cause both acute and chronic disease.

- The virus is most commonly transmitted from mother to child during birth and delivery.

- Hepatitis B can be prevented by vaccines that are safe, available and effective.

Circumcision:

* Is the elective removal of the foreskin of the penis. It's usually performed on a newborn boy before he leaves the hospital, and often within the first 2 days of life.

* Circumcision will be performed with the consent of the parents.

Note: For more information you can ask our neonatal doctors. Circumcision Leaflet is available.

Hearing Screening:

- * One to two babies in every 1,000 are born with permanent hearing loss in one or both ears.
- * This increases to about 1 in every 100 babies who have spent more than 48 hours in intensive care.
- * Most of these babies are born into families with no history of permanent hearing loss.
- * Permanent hearing loss can significantly affect babies' development.
- * Finding out early can give these babies a better chance of developing language, speech, and communication skills.

Important: Children with hearing loss have difficulties with verbal and nonverbal communication; increased behavior problems, decreased psycho-social wellbeing and lower educational attainment compared to children with normal hearing

Detection: Because half of the children with hearing loss have no identifiable risk factors, universal screening is recommended to detect permanent congenital hearing loss. There is good evidence that newborn hearing screening is highly accurate; this leads to early identification and treatment.

Benefits of detection and early treatment:

- * Early detection improves lingual & communication outcomes.

Note: Hearing Screening test leaflet is available.

CCHD Screening:

- Importance of Newborn Screening for Critical Congenital Heart Defects.
- Screening for critical congenital heart defects (critical CHDs) can help identify some babies with a critical CHD before they go home from the birth hospital. This allows these babies to be treated early and may prevent disability or death early in life.

Note: For more info please, refer to CCHD screening leaflet.

Your birth plan is tailored to meet your personal wishes. Keep in mind, there can be circumstances where our team needs to depart from the plan to ensure the safest possible delivery. Remember, the ultimate goal during delivery is to have a healthy mom and a healthy baby. Your birth plan can help communicate your preferences to the care team during one of the most exciting times of your life.